

PSYC1008 - Approche de la démarche clinique en psychologie

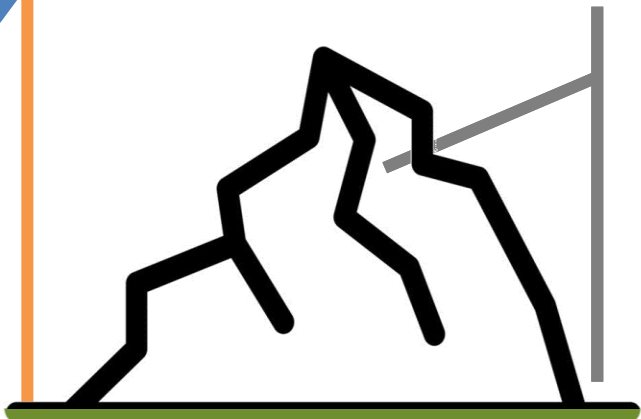
Séance 4
**Communiquer pour soutenir
l'alliance et coconstruire l'entretien**

Trecy Martinez Perez



Démarche clinique en psychologie

Approche Centrée sur la Personne (ACP)



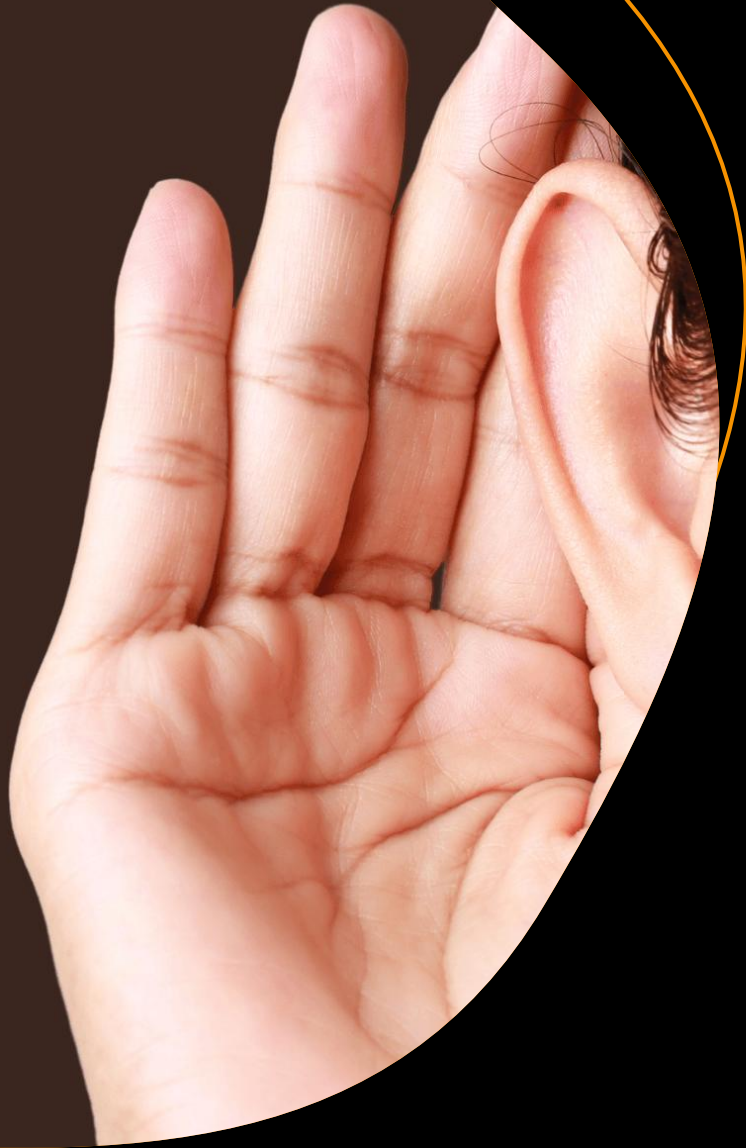
Ce que le psychologue (l'étudiant) fait

4

Quels processus de pensée et de prise de décision (= raisonnement clinique) amènent le psychologue (l'étudiant) à agir ainsi ?

Quelles informations alimentent le raisonnement clinique du psychologue (de l'étudiant) ?





Aujourd'hui

Enjeux de la communication clinicien-patient

Quand mobiliser les techniques de
communication ?

Éventail des techniques

Prochains rendez-vous



Aujourd'hui

Enjeux de la communication clinicien-patient

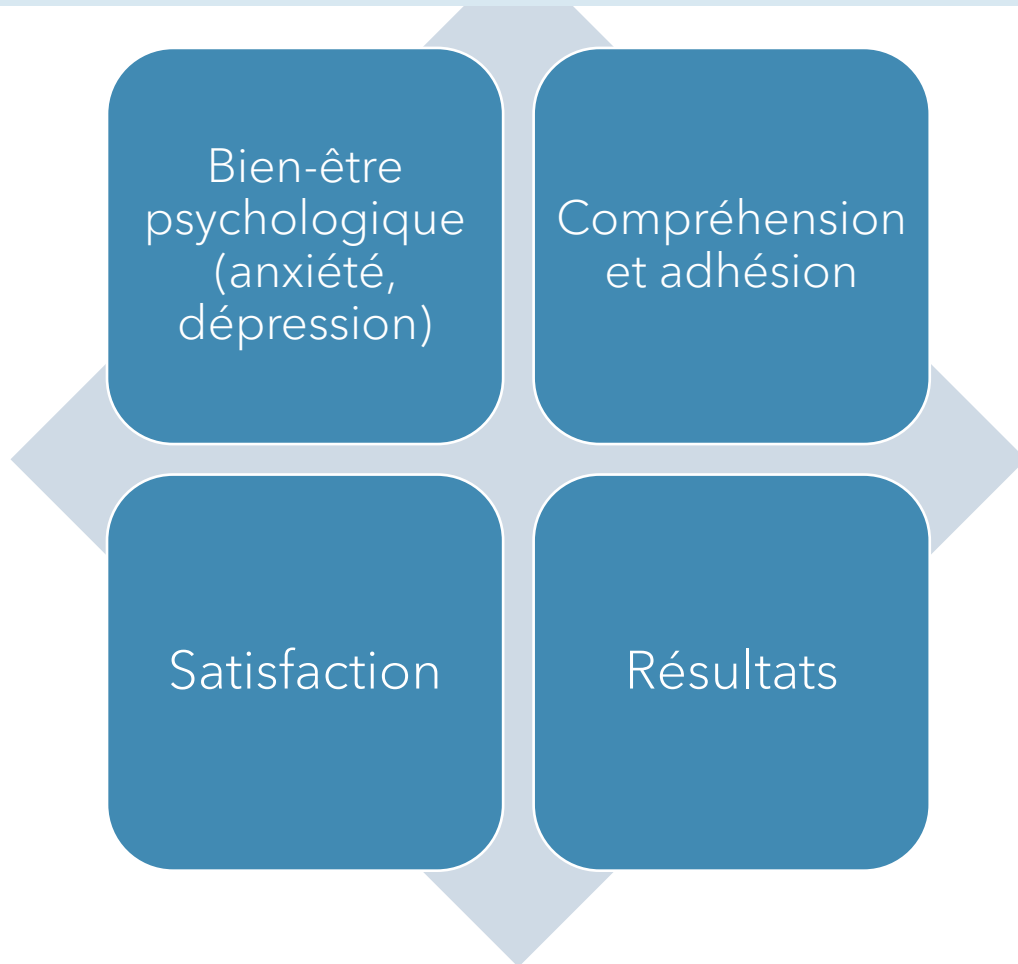
Quand mobiliser les techniques de communication ?

Eventail des techniques

Prochains rendez-vous

Pourquoi ?

Pour le bénéficiaire



Pour le clinicien



Impact de la compréhension partagée

Hypothèse : Les séances précédant la remise de conclusion impactent le processus de prise de décision et acceptation/la résistance au traitement



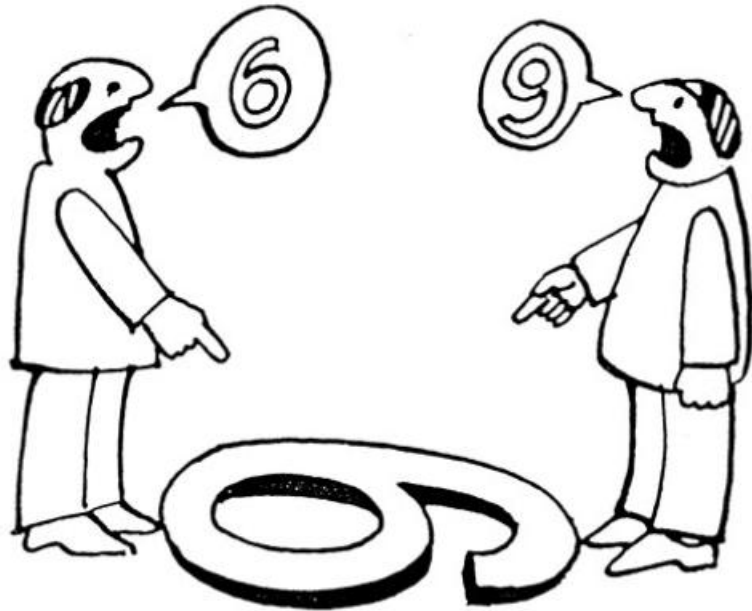
Fait d'explorer le point de vue/avis du bénéficiaire

Favorise son intégration au sein des propositions thérapeutiques

Aide dans le cadre des annonces difficiles & de résistance

Évite les recommandations inadaptées

Difficultés de la compréhension partagée



La perspective est différente : risque
de désaccords quant à la
nature/sévérité du problème

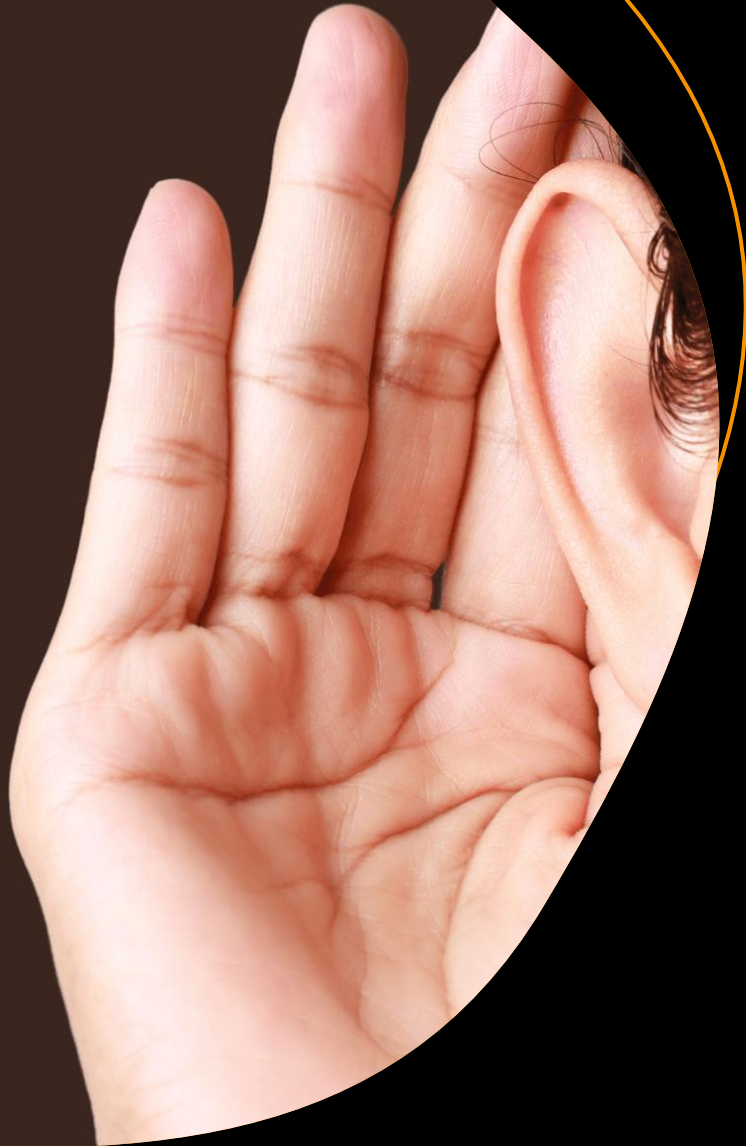


Impact sur la prise de décision

Sentiment d'être compris > confiance

Diapositive de Raphaël Gazon





Aujourd'hui

Enjeux de la communication clinicien-patient

Quand mobiliser les techniques de communication ?

Éventail des techniques

Prochains rendez-vous

Tout le temps

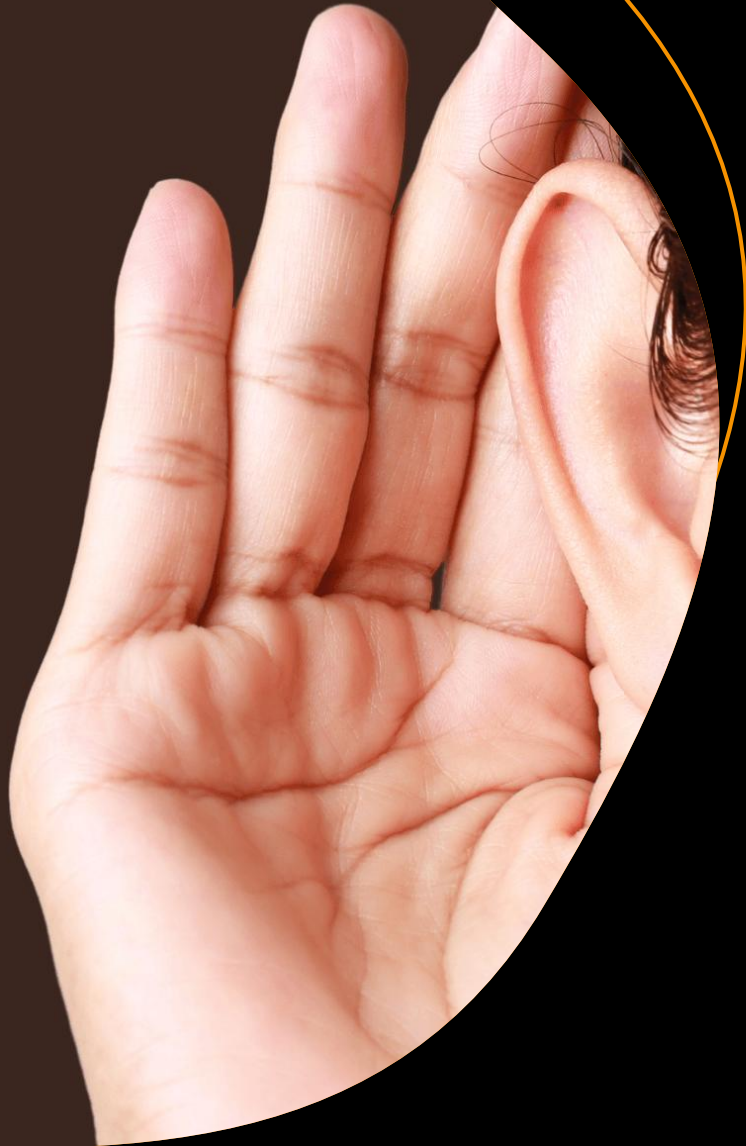
Dès la prise de contact

Pour recueillir des informations sur les difficultés, l'histoire de vie et le contexte, les préférences et valeurs du patient

Et aussi ...

- lors de l'évaluation outillée
- lors de l'entretien de « remise de conclusion »
- lors de l'intervention

Systématiquement, penser à démarrer et définir les objectifs (D) + clôturer (CL) la séance



Aujourd'hui

Enjeux de la communication clinicien-patient

Quand mobiliser les techniques de communication ?

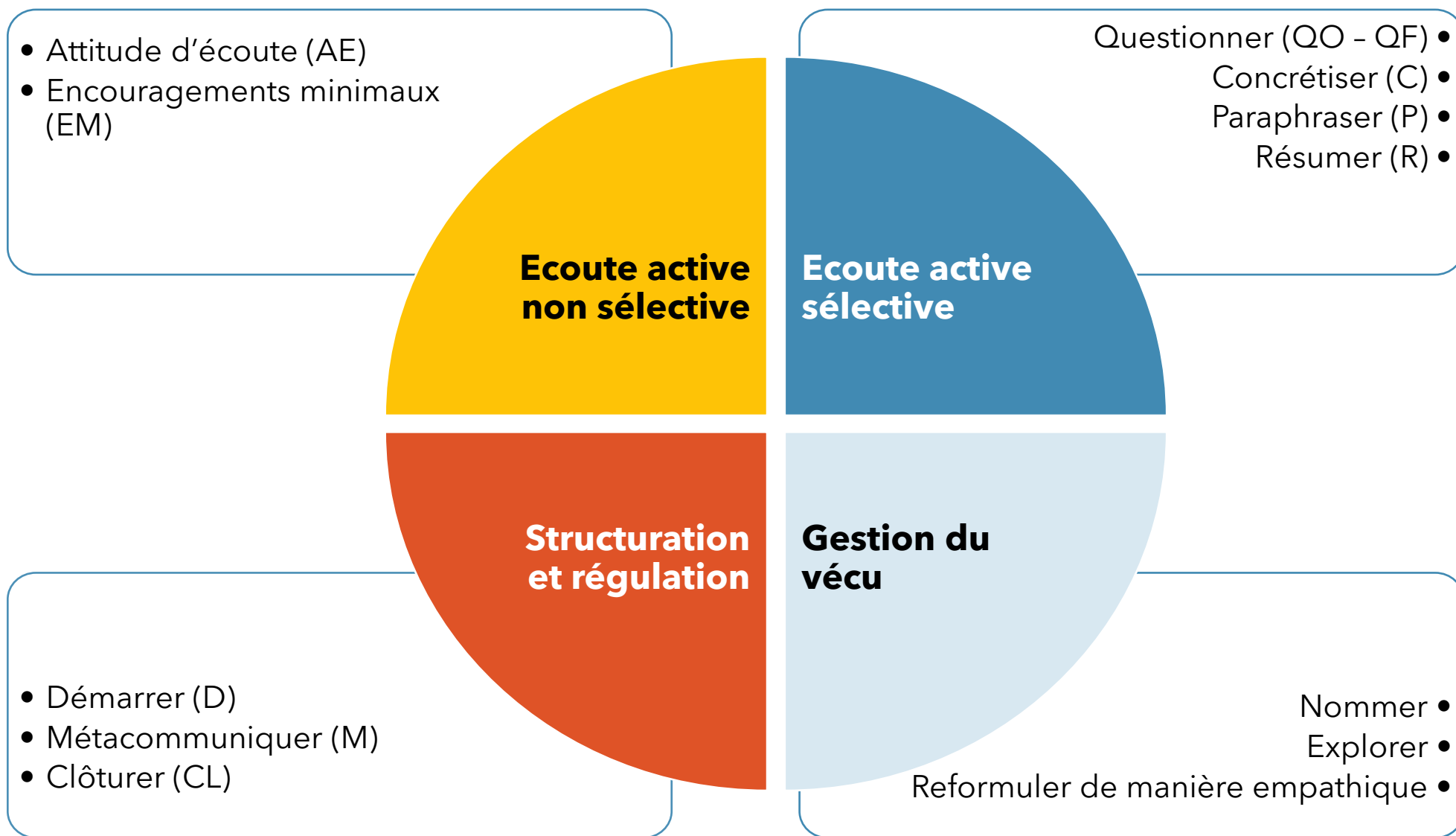
Éventail des techniques

Prochains rendez-vous

Retour sur le TP1

Vidéo 2 :
Le bon entretien

4 « catégories » de techniques à combiner



Côté clinicien

- Attitude d'écoute (AE)
- Encouragements minimaux (EM)

**Ecoute active
non sélective**

**Ecoute active
sélective**

**Structuration
et régulation**

**Gestion du
vécu**

Donner au patient le plus d'espace et de leviers possibles pour raconter son histoire

- Nommer (N)
- Concrétiser (C)
- Paraphraser (P)
- Résumer (R)

Préserver l'objectif de la rencontre et progresser vers cet objectif

insérer

- Nommer
- Explorer
- Reformuler de manière empathique

Côté patient

- Attitude d'écoute (AE)
- Encouragements minimaux (EM)

**Ecoute active
non sélective**

**Ecoute active
sélective**

**Structuration
et régulation**

**Gestion du
vécu**

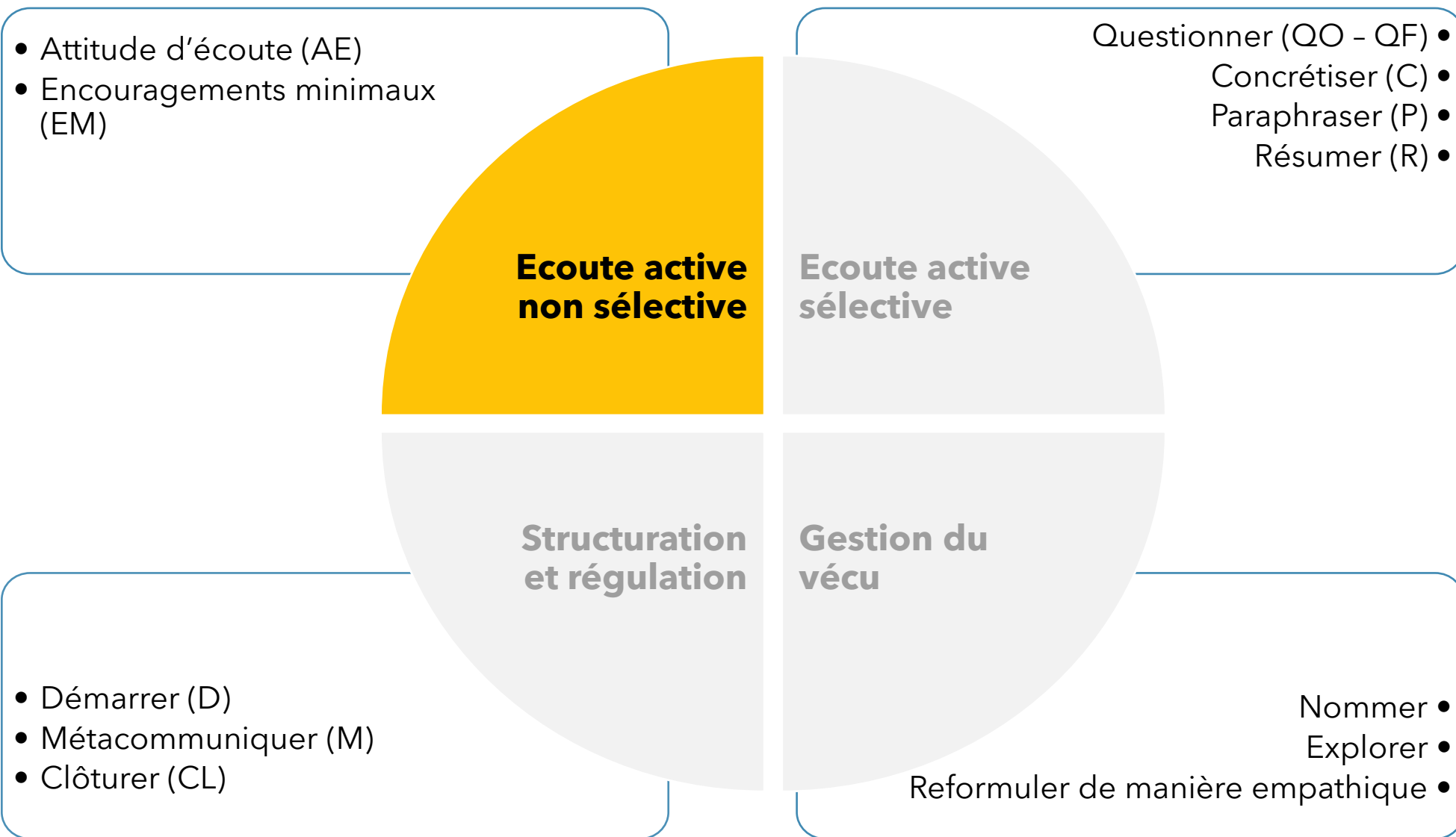
Se sentir compris

- Nommer (N)
- Concrétiser (C)
- Paraphraser (P)
- Résumer (R)

Comprendre la démarche/le processus

- Nommer
- Explorer
- Reformuler de manière empathique

4 « catégories » de techniques à combiner



Ecoute active non-sélective

Attitude d'écoute (AE)

Objectifs : Accorder de l'attention, montrer au patient qu'il est écouté, créer une situation où il peut se sentir en sécurité pour partager son vécu

Comment faire ? Souvent par une attitude **non-verbale** adéquate

- Position du corps (se placer dans les limites de la distance sociale (professionnelle), se pencher vers l'avant, être détendu)
- Expressions faciales (d'ouverture ; chaleur; hochement de tête)
- Regard (garder le contact visuel en parlant avec le patient; trouver un équilibre avec la prise de notes)
- Utilisation intentionnelle d'un silence ni trop long ni trop court

Ecoute active non-sélective

Encouragements minimaux (EM)

Objectifs : Inciter le patient à en dire plus, à poursuivre et l'encourager à parler

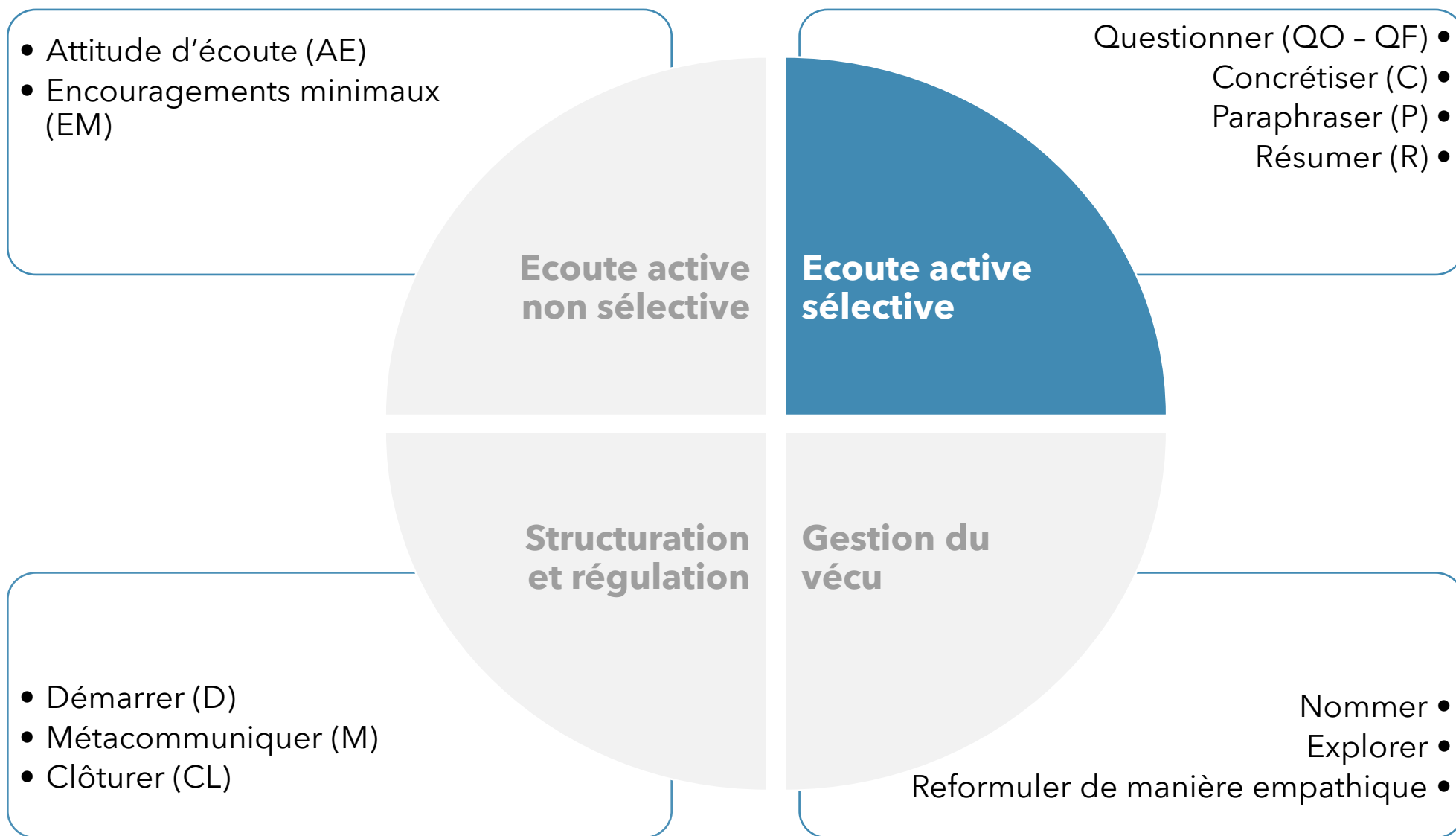
Comment faire ?

- Encouragements minimaux simples pertinents (= interjections : hm hm; oui; ok; oh ?; et alors ? + intonation de la voix : neutre, étonnement, compréhension, renforcement)
- Répétition verbale - relance (= répéter un mot ou une phrase du patient avec un ton interrogatif)

Exercise



4 « catégories » de techniques à combiner



Ecoute active sélective

Questionner (QO - QF)

Objectifs : Permettre au patient de clarifier ses besoins et ses attentes, de raconter son histoire, de mieux comprendre son histoire de vie, son contexte, ses valeurs,

Comment faire ?

- Questions ouvertes (Comment ? Qu'est-ce que ? Pouvez-vous me décrire... Parlez-moi de ...)
- Questions fermées (quand on a besoin d'une information précise ou spécifique, démarrer l'échange avec un enfant timide ou un adolescent récalcitrant, ...)

Passer de l'une à l'autre
de façon appropriée

Exercice : ne poser QUE des QO

En trinôme

Sur le thème des loisirs

- 1 étudiant·e pose les questions
- 1 étudiant·e répond aux questions
- 1 étudiant·e écoute et note le nombre de QO (jusqu'à arriver à 5QO ou 1 QF)

Changer les rôles si 1 QF ou si 5 QO

Ecoute active sélective

Concrétiser (C)

Objectifs : Rendre les propos concrets et contextualiser le problème

Comment faire ?

- QO-QF, paraphrase (Comment cela se manifeste au travail ?)
- Demander un exemple (Est-ce que vous pourriez me donner un exemple de problème de mémoire ?)
- Demander de l'aide (quand vous dites « », qu'entendez-vous par là ?)

Ecoute active sélective

Paraphraser (P) ou Reformuler

Objectifs : Encourager le patient à préciser son propos, vérifier notre compréhension, montrer au patient qu'il a bien été entendu

Comment faire ?

- Utiliser d'autres mots pour exprimer la même idée
- Introduire la reformulation (Ainsi, selon vous... En d'autres termes... Si je vous ai bien suivi...)
- Vérifier l'exactitude (intonation interrogative, demande explicite : c'est bien ça ?)
- Patient : C'est vraiment difficile pour moi de contrôler ces pensées ; dès que la première arrive, elles s'enchainent toutes et j'ai l'impression de ne plus avoir aucun contrôle.
- Psychologue : C'est comme si vous vous sentiez piégé par plein de pensées, que vous avez le sentiment de ne plus pouvoir arrêter ?
- La reformulation porte sur une seule idée et suit directement les propos de la personne

Ecoute active sélective

Résumer (R)

Objectifs : Structurer et ordonner l'histoire du patient et vérifier que l'histoire du patient a bien été comprise

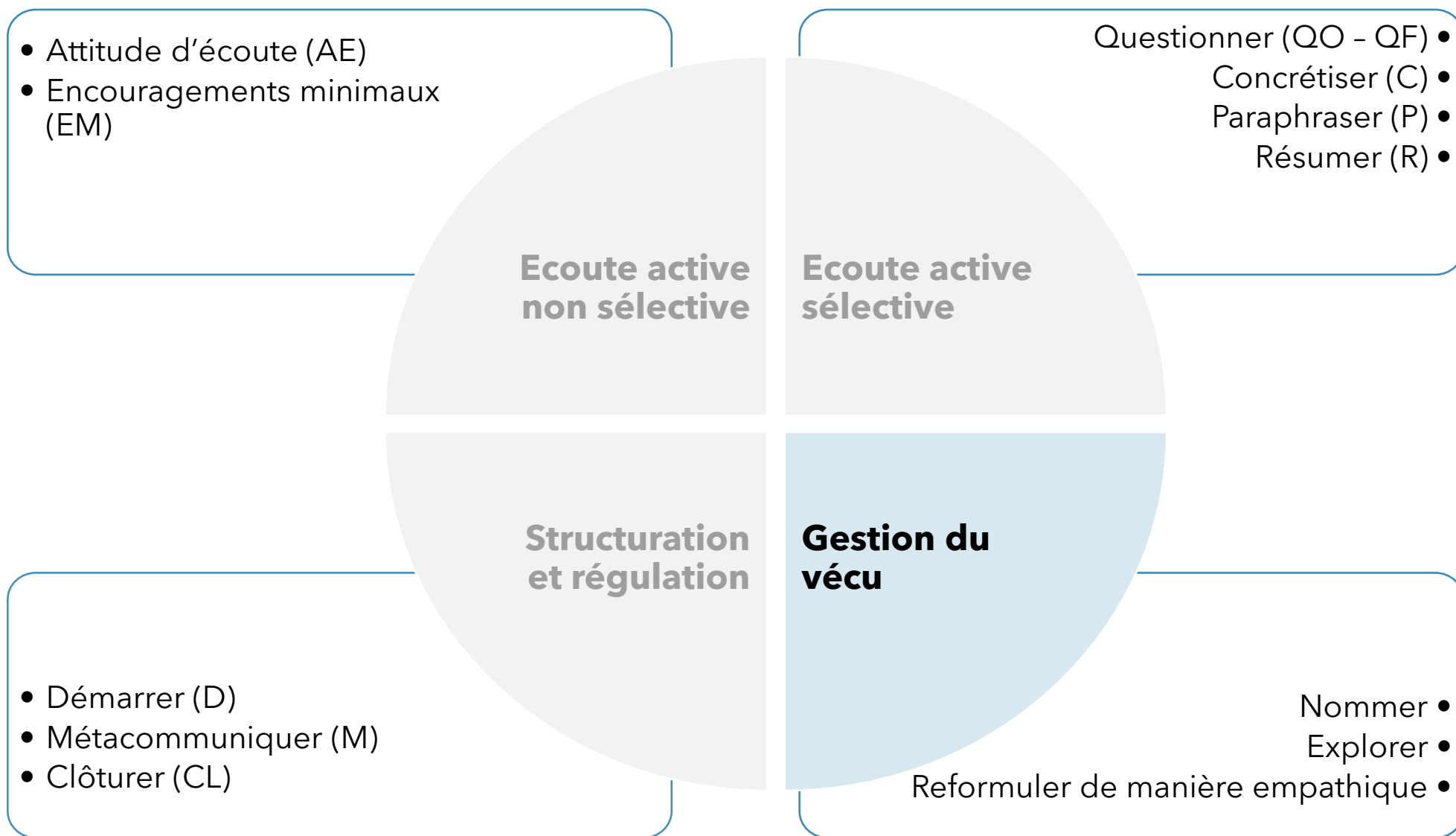
Comment faire ?

- L'annoncer
- Décrire le contenu essentiel et les émotions clés
- Utiliser des mots accessibles
- Vérifier l'exactitude
- Le résumé porte sur plusieurs idées, qui sont réorganisées d'une manière claire



Exercice : Suivre le propos de l'autre

4 « catégories » de techniques à combiner



Gestion du vécu

Objectifs : Faire preuve de compréhension et d'empathie vis-à-vis du vécu exprimé par le patient, encourager le patient à exprimer son vécu, vérifier notre compréhension du vécu

Comment faire ?

- Nommer le vécu
- Explorer le vécu
- Reformuler de manière empathique



Gradation dans les compétences
+
Reformuler n'a du sens/de la pertinence
que si l'exploration a été suffisante

Gestion du vécu

(1) Nommer

L'intention est de reconnaître que la personne traverse un vécu particulier

Comment faire ?

- Mieux vaut se tromper qu'ignorer ! Patients tolèrent mieux une erreur dans l'interprétation d'un indice émotionnel qu'une absence de détection (Blach-Hartigan, 2013)
- Mettre des mots sur l'émotion (+ intensité)
 - De façon générale : "Je vois que c'est difficile pour vous" , « Ça semble difficile d'en parler ...? », « Ça fait beaucoup de choses à encaisser »,
 - De façon plus précise : "Vous semblez surchargé·e/triste/en colère, ... », « Est-ce qu'on peut dire que c'est de la panique ? », « Cela doit être difficile de porter cette charge seule »

Gestion du vécu

(2) Explorer

L'intention est de comprendre le vécu de la personne de manière complète

Comment faire ?

- Poser une question qui vise à approfondir le vécu
 - *“Qu'est-ce qui vous met le plus en colère dans la situation ?”*
 - *« Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qui se passe pour vous dans ces moments-là ? »*
 - *« Cette culpabilité, elle se traduit comment ? »*

Gestion du vécu

(3) Refléter de manière empathique

L'intention est de pouvoir manifester de l'empathie et mettre en perspective le vécu

Comment faire ?

- le propos manifeste de l'empathie ET lie explicitement des éléments situationnels concrets avec le vécu
- « Votre grand-mère semble avoir joué un rôle important dans votre vie, elle s'est beaucoup occupée de vous, j'imagine à quel point cela doit être difficile de la voir si diminuée aujourd'hui »,
- « Vous avez deux enfants en bas âge et vous semblez porter la majorité des responsabilités seule, ça doit être une charge vraiment lourde à porter »

Gestion du vécu

Points d'attention

1) Evitement

Lorsque l'étudiant·e change de sujet, répond sans manifester de signe d'écoute active, fait un résumé sans revenir spécifiquement sur le vécu, apporte ou recherche des solutions directement après l'expression d'un vécu difficile.

Exemples : « Patient·e : Ma grand-mère est décédée le mois dernier c'est vraiment compliqué pour moi – Psychologue : D'accord, donc si je résume ce qui vous amène, ... »

Patiente : Je me sens épuisée avec mes deux petites, c'est vraiment difficile seule au quotidien – Psychologue : Vous devriez essayer de prendre un peu de temps pour vous OU Est-ce que vous en avez déjà parlé à quelqu'un/mis quelque chose en place ? »

Gestion du vécu

Points d'attention

2) Minimisation

Exemples : un patient vient pour des troubles de la mémoire ; le psychologue, en résumant, dit : « Concernant les *petits problèmes* de mémoire »

3) Banalisation

Exemples : Une patiente dit souffrir de la distance avec sa mère depuis que cette dernière s'est mise en couple avec son nouveau compagnon ; la psychologue : « C'est normal d'être triste quand on s'éloigne, mais ça fait partie de la vie ».

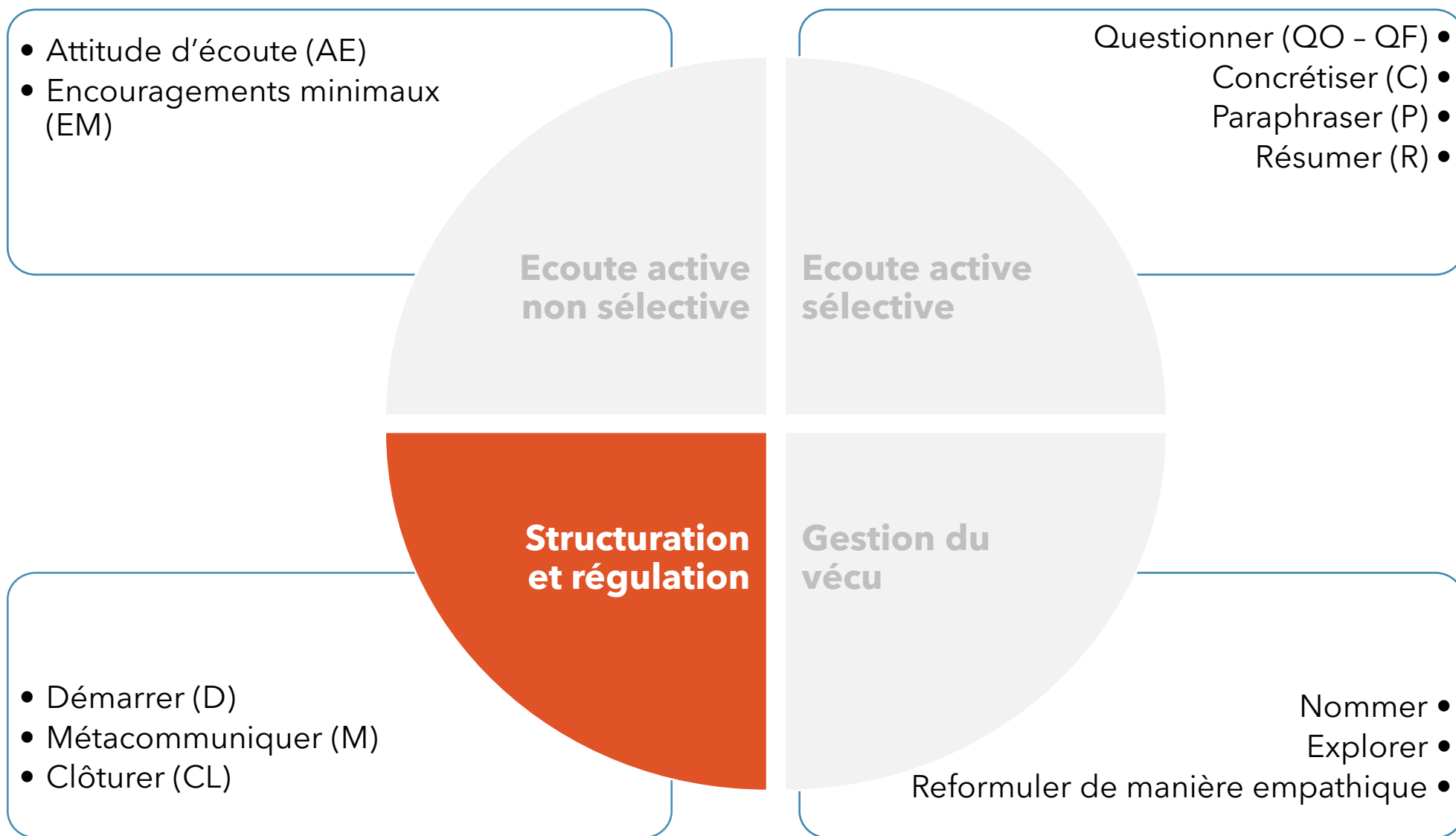
Exercise 3 – Version a



Exercise 3 – Version b



4 « catégories » de techniques à combiner



Structuration et régulation

Démarrer (D)

Objectifs : Poser le cadre, fixer des objectifs, favoriser le partenariat

Comment ? 1^{er} entretien

- Saluer le patient et se présenter
- Expliquer l'objectif de la séance : compréhension de la demande / exploration des difficultés (« L'objectif est de comprendre les difficultés que vous rencontrez et comment elles se manifestent dans différents domaines de votre vie » KO = «L'objectif est de faire connaissance »)
- Expliquer le fonctionnement (durée, confidentialité,)
- Demander explicitement le consentement/l'accord de la personne sur l'ensemble du cadre et attendre sa réponse (« Est-ce que la façon dont je vous propose de fonctionner vous convient ? »)
- Questionner la raison de consultation par une QO (« Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qui vous amène ? »)

Structuration et régulation

Démarrer (D)

Objectifs : Placer le cadre, fixer des objectifs, favoriser le partenariat

Comment ? Entretiens suivants

- Accueillir (échanges quelques banalités, s'enquérir de l'état du patient au moment présent)
- Synthétiser la précédente rencontre
- Proposer un objectif pour cette rencontre-ci et obtenir l'accord du patient

Structuration et régulation

Métacommuniquer

Régulation de l'entretien

L'intervention du psychologue permet de structurer l'entretien, d'explicitier une transition ou d'expliquer la raison de sa question, son résumé, ...

« Vous me parlez de 2 choses. On va se focaliser sur chaque élément » ; « Vous me disiez en début de séance, ... »

« *Si on peut structurer les événements ensemble, ceci est arrivé il y a combien de temps ? ...* »

« Je vous pose cette question parce que ... »

« Je vous propose de résumer ce que l'on vient de dire *pour m'assurer d'avoir bien compris* »

Structuration et régulation

Métacommuniquer

Pensée à voix haute

Le psychologue verbalise son propre processus cognitif ou décisionnel de manière transparente

« Je réfléchis à comment formuler ma question » ; « Je réfléchis à tout ce que vous venez de me dire » ; « Je cherche un peu mes mots pour rediriger la séance »

Hypothèses de lien

Le psychologue formule une hypothèse sur le vécu ou le fonctionnement du patient **A CONDITION QUE** cette hypothèse s'appuie sur suffisamment d'éléments amenés dans l'entretien (raisonnement clinique fondé) et que le psychologue laisse à la personne la possibilité de confirmer ou d'infirmer

« J'ai l'impression, corrigez-moi si je me trompe, ... ? »

Structuration et régulation

Clôturer (CL)

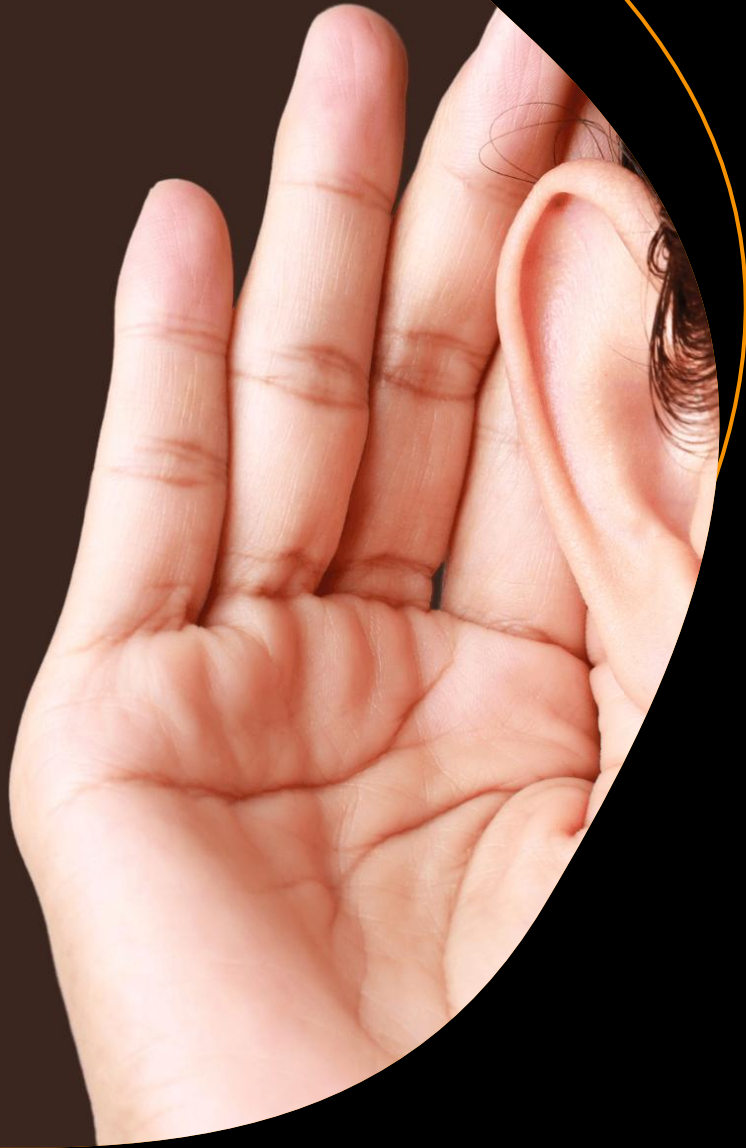
Objectifs : Permettre que la séance soit fermée sur elle-même

Comment ?

- Commencer la clôture à temps
- Formuler une phrase de clôture claire (« Nous arrivons au terme du temps que nous nous étions fixé. Je vais à présent réaliser une synthèse des éléments importants dont nous avons discuté) »
- Résumer ce qui a été convenu (les éléments factuels + le vécu/les émotions principales amenées par la personne et connecter correctement ces deux aspects)
- Vérifier explicitement l'exactitude du résumé (« Est-ce que cela vous semble complet ? », « Est-ce que tout cela correspond bien à ce que vous avez dit ? »)



Exercice 4 : Débuter un entretien



Aujourd'hui

Enjeux de la communication clinicien-patient

Quand mobiliser les techniques de
communication ?

Éventail des techniques

Prochains rendez-vous

Prochains cours

1^{er} octobre : eCampus - Comprendre les techniques de communication

7 octobre : S'initier à la conceptualisation de cas (avec Aurélie Wagener)